

INFECÇÃO DENTAL GRAVE — VIA AÉREA + DRENAR + ATB

DA INFECÇÃO LOCAL À DISSEMINAÇÃO FASCIAL

Estágio	Características	Conduta
Local (periapical)	Dor, edema localizado, dente comprometido	Drenagem/tratamento do dente; ATB se sistêmico
Celulite facial	Edema difuso, dor, calor, eritema da face	ATB + drenagem da fonte; avaliar gravidade
Disseminação para espaços fasciais	Submandibular, sublingual, submental, mastigatório, cervical	Internação + ATB IV + drenagem cirúrgica
Angina de Ludwig	Celulite bilateral de assoalho de boca, elevação da língua	EMERGÊNCIA de via aérea + ATB IV + drenagem
Repercussão sistêmica/sepses	Febre alta, taquicardia, prostração, sinais de sepsis	Ressuscitação + ATB IV precoce + controle da fonte

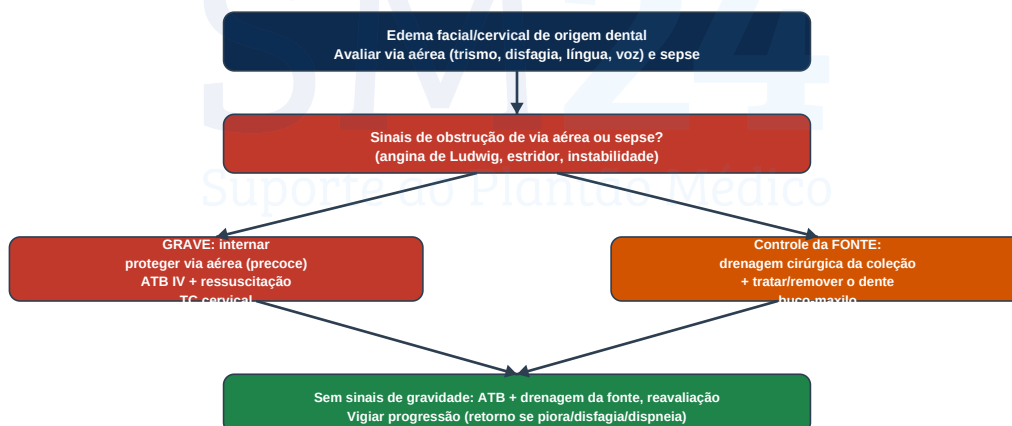
SINAIS DE GRAVIDADE — VIA AÉREA EM PRIMEIRO LUGAR

A INFECÇÃO DENTAL PODE MATAR PELA VIA AÉREA E PELA SEPSIS

- Sinais de alarme: trismo, disfagia, sialorreia, elevação/deslocamento da língua, voz abafada, edema cervical, estridor
- Angina de Ludwig: celulite bilateral de assoalho de boca com risco de obstrução de via aérea — emergência
- Disseminação para o espaço cervical profundo / mediastinite: dor torácica, alargamento do mediastino — alta mortalidade
- Trombose do seio cavernoso: extensão de infecção da face/órbita
- Conduta: proteger a VIA AÉREA precocemente + antibiótico IV + DRENAGEM cirúrgica da coleção + tratar/remover o dente
- TC cervical com contraste para definir a extensão e localizar abscessos

ABORDAGEM DA INFECÇÃO ODONTOGÊNICA GRAVE

INFECÇÃO DENTAL -> AVALIAR VIA AÉREA E SEPSIS



ANTIBIOTICOTERAPIA E SUPORTE

Rx COBRIR FLORA ORAL (ESTREPTO + ANAERÓBIOS)

Leve/moderada (ambulatorial, sem sistêmico): amoxicilina-clavulanato VO; alergia a penicilina: clindamicina VO
Grave / internado: ampicilina-sulbactam IV OU ceftriaxona + metronidazol; clindamicina IV se alergia
Ajustar conforme a gravidade e a resposta; descalonar com a evolução
Antibiótico NUNCA substitui o controle da fonte: drenagem da coleção + tratamento/remoção do dente
Analgesia (dipirona/AINE +/- opioide) e hidratação
Ressuscitação volêmica e cuidados de sepse se repercussão sistêmica
TC cervical com contraste para mapear abscessos e a extensão fascial

COMPLICAÇÕES E VIA AÉREA

Complicações Graves

- Angina de Ludwig (obstrução de via aérea)
- Mediastinite descendente (alta mortalidade)
- Trombose de seio cavernoso
- Abscesso cervical profundo / fasciíte cervical
- Sepses e choque séptico
- Trombose de veia jugular (síndrome de Lemierre)

Manejo da Via Aérea

- Antecipar a dificuldade (trismo, edema, distorção anatômica)
- Proteger a via aérea precocemente — não esperar a obstrução total
- Intubação idealmente em centro cirúrgico, com equipe e plano para via cirúrgica
- Manter o paciente sentado/confortável; O₂
- Acionar anestesia + buco-maxilo/cirurgia de cabeça e pescoço
- Cricotireoidostomia/traqueostomia se necessário

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Avaliar a via aérea (trismo, disfagia, elevação da língua, voz, estridor) e os sinais de sepse
- ☐ Angina de Ludwig / obstrução iminente: emergência — proteger a via aérea precocemente
- ☐ Antibiótico IV de amplo espectro cobrindo flora oral (estrepto + anaeróbios) e ressuscitação na sepse
- ☐ Controle da FONTE: drenagem cirúrgica da coleção + tratamento/remoção do dente (o ATB não basta)
- ☐ TC cervical com contraste para mapear a extensão e abscessos
- ☐ Acionar buco-maxilo/cirurgia de cabeça e pescoço e anestesia; vigiar mediastinite

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com infecção dentária evolui com edema bilateral de assoalho de boca, elevação da língua e dificuldade para respirar. Qual o diagnóstico e a prioridade?

- A) Celulite pré-septal — antibiótico oral
- B) Angina de Ludwig — emergência: proteger a via aérea precocemente, ATB IV e drenagem
- C) Sinusite — descongestionante
- D) Faringite viral — sintomáticos
- E) Abscesso periapical simples — alta com analgésico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a base do tratamento da infecção odontogênica com coleção purulenta, além do antibiótico?

- A) Apenas observação
- B) Controle da fonte: drenagem cirúrgica da coleção e tratamento/remoção do dente
- C) Corticoide isolado
- D) Antitérmico
- E) Bochechos apenas

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual antibiótico empírico é adequado para infecção odontogênica grave (internado)?

- A) Ciprofloxacino isolado
- B) Ampicilina-sulbactam IV (ou ceftriaxona + metronidazol); clindamicina se alergia a penicilina
- C) Azitromicina oral
- D) Nitrofurantoína
- E) Vancomicina isolada

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual complicação de alta mortalidade pode resultar da disseminação cervical profunda de uma infecção odontogênica?

- A) Conjuntivite
- B) Mediastinite descendente
- C) Otite externa
- D) Gengivite
- E) Cárie dentária

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual exame de imagem é indicado para mapear a extensão e localizar abscessos na infecção odontogênica grave?

- A) Radiografia panorâmica isolada
- B) TC cervical com contraste
- C) Ultrassonografia abdominal
- D) Eletroencefalograma
- E) Radiografia de tórax apenas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Edema bilateral de assoalho de boca + elevação da língua + dispneia de origem dental caracteriza a angina de Ludwig — emergência de via aérea. A prioridade é proteger a via aérea precocemente, com antibiótico IV e drenagem cirúrgica, em ambiente preparado.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O controle da fonte é a base: drenagem cirúrgica da coleção purulenta e tratamento/remoção do dente causador. O antibiótico é adjuvante e nunca substitui a drenagem e a eliminação do foco.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na infecção odontogênica grave, o esquema empírico deve cobrir a flora oral (estreptococos e anaeróbios): ampicilina-sulbactam IV ou ceftriaxona + metronidazol; clindamicina IV é alternativa em alérgicos à penicilina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A disseminação para o espaço cervical profundo pode descer pelo mediastino e causar mediastinite descendente, complicação de alta mortalidade. Por isso a infecção odontogênica grave exige controle precoce da fonte e vigilância.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A TC cervical com contraste é o exame indicado para mapear a extensão da infecção pelos espaços fasciais, localizar abscessos drenáveis e avaliar o comprometimento da via aérea e do mediastino.

SM24
Suporte ao Plantão Médico